游戏结合言语训练在 2～5 岁语言发育迟缓高危儿童康复中的应用效果

赵丽丽　王 芮

宁夏残疾人康复中心，宁夏 银川 750011

摘　要：目的：浅析 2～5 岁语言发育迟缓高危儿童采用游戏结合言语训练进行康复指导的效果。方法：选取 2024 年 2 月至 2025 年 1 月本院接受治疗的 2～5 岁语言发育迟缓高危儿童 50 例，采取随机原则分组，对照组为常规语言训练，观察组为游戏结合言语训练，对比康复护理效果。结果：观察组患儿格赛尔幼儿发育量表评分高于对照组，对比差异显著（P＜0.05）；此外，观察组患儿 S-S 语言发育迟缓检查法各项评分优于对照组，对比差异显著（P＜0.05）。结论：针对 2～5 岁语言发育迟缓高危儿童实施游戏结合言语训练的效果显著，有助于改善患患儿的语言能力和语言发育水平，干预效果确切。

关键词：游戏训练；言语训练；2～5 岁儿童；语言发育迟缓；高危儿童

语言发育迟缓是儿童早期最常见的发育障碍之一，对患儿的社交互动、认知发展及未来学业均构成深远影响。2～5 岁是语言能力发展的黄金时期，及时有效的康复干预对改善预后至关重要[1]。然而，当前传统的言语训练模式往往较为枯燥、刻板，难以激发低龄儿童，尤其是语言发育迟缓高危儿童的参与兴趣与主动性，导致训练依从性差，康复效果不尽理想[2]。游戏是儿童的天性，是其探索世界、学习知识的主要方式。将言语训练目标巧妙地融入到生动有趣的游戏情境中，不仅能显著提升患儿的参与度和依从性，还能在轻松愉悦的氛围中促进其语言理解与表达能力的自然发展[3]，因此，探索一种更符合儿童身心发展特点的康复模式具有重要的临床意义。鉴于此，选取 2024 年 2 月至 2025 年 1 月本院接受治疗的 2～5 岁语言发育迟缓高危儿童 50 例，现将内容报道如下。

1　资料与方法

1.1　一般资料

选取 2024 年 2 月至 2025 年 1 月本院接受治疗的 2～5 岁语言发育迟缓高危儿童 50 例，依照数字随机分组法分为 2 组。对临床资料进行整理分析，观察组男 12 例，女 13 例；年龄在 2-5 岁，平均年龄（3.94±0.96）岁。对照组男 14 例，女 11 例；年龄在 2-5 岁，平均年龄（3.89±0.93）岁。两组患者一般临床资料如性别，年龄及病程比较，均无统计学差异，有可比性，可作为下文治疗效果比较的依据。

1.2　干预方法

对照组患儿接受常规语言训练护理，护士主要扮演指导者和监督者的角色。具体措施包括：在安静的治疗室内，由护士或康复师对患儿进行一对一的指导，使用标准化的卡片、图谱等教具，进行命名、跟读、问答等重复性练习，以强化其对特定词汇、句式的记忆与模仿；当患儿发音不准或表达错误时，护士会及时给予直接纠正；同时，护士会向家长发放训练任务清单，指导其回家后继续进行类似的机械性练习，并定期检查完成情况。

观察组则在对照组基础上实施以游戏为核心的综合性护理干预，护士的角色转变为游戏的精心设计者、热情的参与者和巧妙的引导者。护士首先根据每位患儿的兴趣点和语言能力短板，设计个性化的游戏方案，将发音、词汇、语法、理解和逻辑等训练目标无痕融入“超市购物”、“厨房帮手”、“给娃娃穿衣”、“搭积木讲故事”等生活化、情景化的游戏中。在游戏过程中，护士作为玩伴，通过丰富的表情、夸张的语调和生动的肢体语言，为患儿提供大量可理解的语言输入，并利用自然情境引导和鼓励患-儿主动表达，例如在“超市购物”中引导其说出“我要买苹果”而非简单指向。对于患儿的任何沟通尝试，护士都给予积极的反馈和鼓励，不过分纠结于发音的准确性，重在建立其沟通的自信心和乐趣。此外，对家长的护理指导也从“布置任务”转变为“教授方法”，教会家长如何在日常的亲子互动中发现和创造游戏机会，将言语

中国知网　https://www.cnki.net

训练融入洗澡、吃饭、散步等各个生活环节，使康复训练生活化、持续化。

1.3 评价标准

对比幼儿智力发育情况，采用格塞尔婴幼儿发展量表（gesell developmental schedules，GESELL）评估并比较两组患儿智力情况，该量表涉及 5 个能区：适应行为、大运动行为、精细运动行为、语言行为、个人-社交行为，评分越高智力情况越好。

对比语言能力，采用 S-S 语言发育迟缓检查表，从三个方面评估，分别是语言表达、语言能力和语言操作，单项的分值在 0-60 分，分值高，则表明语言功能恢复更好。

1.4 统计方法

由 SPSS 17.0 完成，得出具有推广性质的结论。计量资料的描述方式为“均数±标准差”，两组样本计量资料的检验方法为 t 检验，计数资料（n，%）采用卡方检验，以 P＜0.05 有统计学意义的前提。

2 结果

2.1 对比儿童发育情况

观察组患儿格赛尔幼儿发育量表评分高于对照组，对比差异显著（P＜0.05）。见表 1。

表 1 两组患儿 Gesell 发育量表结果对比（$\bar{x}$±s，分）

组别	精细运动行为	适应行为	个人社交行为	大运动行为	语言行为
对照组（N=25）	85.63±4.36	82.63±4.53	83.03±6.39	88.23±5.49	81.45±7.58
观察组（N=25）	91.34±5.13	87.66±4.41	90.12±3.63	93.45±6.58	87.98±6.24
T	6.635	6.363	5.134	5.498	6.432
P	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05

2.2 对比语言发育情况

观察组患儿 S-S 语言发育迟缓检查法各项评分优于对照组，对比差异显著（P＜0.05）。见表 2。

表 2 两组患者儿 S-S 语言发育迟缓检查法对比（$\bar{x}$±s，分）

组别	语言表达		语言能力		语言操作	
	干预前	干预 3 个月后	干预前	干预 3 个月后	干预前	干预 3 个月后
对照组（N=25）	41.63 ± 5.56	43.31±7.25	38.75 ± 3.80	44.14±1.52	39.30 ± 6.55	42.61±7.07
观察组（N=25）	41.63 ± 5.39	46.52±7.30	37.63 ± 2.54	47.58±1.54	39.69 ± 6.46	45.55±7.48
T	0.175	3.635	0.356	4.856	0.215	3.846
P	＞0.05	＜0.05	＞0.05	＜0.05	＞0.05	＜0.05

3 讨论

2～5 岁语言发育迟缓高危儿童的病情特点主要表现为语言能力全面落后于同龄正常儿童。在语言理解层面，患儿常难以听懂稍复杂的指令或问题，对抽象概念的掌握存在困难[4]。而在语言表达层面，其突出表现为词汇量极为有限，无法组织合乎语法的句子，多以单词或简单词组进行沟通，且常伴有发音不清、吐字含糊等构音问题[5]。这些核心障碍导致他们难以进行有效的社会交往，无法融入同伴游戏，并可能因沟通受挫而表现出注意力不集中、急躁、退缩等行为问题，严重影响其认知及社会情感的健康发展[6]。

据悉，传统训练模式因其枯燥性和脱离语境的特点，难以有效激发儿童学习兴趣，导致依从性差、泛化能力不足。而游戏化干预则充分利用儿童天性，将语言学习融入生动、愉悦的互动情境，显著提升了患儿的参与度、主动性和沟通动机[7]。这种以儿童为中心、情境化的教学方式，不仅促进了语言理解与表达的

中国知网 https://www.cnki.net

自然习得，更重要的是，它降低了儿童的焦虑感，增强了其沟通自信，并有助于语言技能在日常生活中的泛化应用[8]。此外，游戏模式易于家长掌握并融入家庭生活，实现了康复的持续性。因此，对于 2～5 岁语言发育迟缓高危儿童，康复的要点在于早期、个性化、趣味性、情境化，并强调家庭参与，以构建一个支持性、互动性的语言学习环境[9]。

本次研究数据显示，观察组患儿在格赛尔幼儿发育量表及 S-S 语言发育迟缓检查法中的各项评分均显著优于对照组（P＜0.05），其根本原因在于两种康复模式在核心机制上的显著差异。对照组所采用的传统言语训练，往往模式化、重复性强，易使儿童感到枯燥乏味，从而产生抵触情绪，导致训练依从性低，效果难以泛化。而观察组将游戏与训练相结合，精准抓住了 2～5 岁儿童以玩乐为天性的心理特点。在游戏中，语言学习不再是孤立、抽象的任务，而是被融入到具体、生动且充满趣味的互动情境中[10]。这极大地激发了患儿主动沟通的内在动机与需求，促使其在自然状态下练习语言理解与表达，从而全面提升了 S-S 量表所测查的各项语言能力。更重要的是，语言能力的提升促进了患儿的社会交往、情绪调控及问题解决能力，这种积极的连锁反应全面带动了其在适应行为、个人-社交等领域的综合发展，因此在衡量整体发育水平的格赛尔评估中也表现出显著优势。

简而言之，游戏化干预对 2～5 岁语言发育迟缓高危儿童而言能够实现语言技能与综合能力的协同进步，通过将“要我学”转变为“我要学”，最终取得了不错的成效。

参考文献

[1]赵小燕,李娟,陈莲,等.游戏结合言语训练在 2～5 岁语言发育迟缓高危儿童康复护理中的作用评价[J].智慧健康,2025,11(18):163-166.

[2]杜莉萍.针刺结合言语训练在语言发育迟缓儿童中的应用研究[J].中外医药研究,2025,4(11):64-66.

[3]谢芝.脑循环治疗仪配合游戏辅助言语训练在语言发育迟缓儿童中的应用效果[J].中国医药指南,2025,23(09):114-117.

[4]韩雪.认知言语训练在儿童语言发育迟缓中的应用价值[J].名医,2024,(10):15-17.

[5]宋国英.感觉统合训练结合言语训练在语言发育迟缓患儿康复护理中的应用[J].名医,2022,(15):117-119.

[6]陈群雅.针刺治疗儿童语言发育迟缓的系统评价和 Meta 分析[D].广州中医药大学,2022.

[7]刘翠娟.沙盘游戏结合言语训练在语言发育迟缓患儿康复护理中的应用效果观察[J].反射疗法与康复医学,2022,3(07):167-170.

[8]吴素华,毕圣洁.游戏结合言语训练在 2～5 岁语言发育迟缓患儿康复护理中的应用[J].中外医学研究,2022,20(08):104-107.

[9]黄小莉.言语训练结合经颅磁刺激用于儿童语言发育迟缓中的有效性分析[J].名医,2022,(05):27-29.

[10]庞慧.游戏结合言语训练在 2～5 岁语言发育迟缓高危儿童康复护理中的应用效果[J].中西医结合护理(中英文),2021,7(10):82-84.

中国知网 https://www.cnki.net